جزوهٔ سلامت و بهداشت

فصل اول (سلامت) ـ درس ۱: سلامت چیست؟

درس: سلامت و بهداشت ـ پایه دوازدهم

تاریخ: 9 مهر 1405

فهرست مطالب

۰. شناسنامه و فهرست منابع ۳

۱. نقشه کلی درس در یک نگاه ۳

۲. کلیدواژه‌نامه جامع (واژه‌نامه منبع‌محور) ۴

۳. بدنه اصلی آموزشی درس اول ۶

۴. جداول تجمیعی و خلاصه سراسری ۱۳

۵. جمع‌بندی یک‌صفحه‌ای ۱۵

۶. خودآزمایی (۱۵ سؤال امتحانی + پاسخ‌نامه ارجاع‌دار) ۱۵

۷. شکاف‌های دانش (موضوعات ناموجود در منبع) ۱۸

۸. چک‌لیست کیفیت و خودبازبینی ۱۸

۰. شناسنامه و فهرست منابع

- **نام درس:** سلامت و بهداشت [۱]
- **موضوع:** فصل اول (سلامت) ـ درس ۱: سلامت چیست؟ [۱]
- **پایه و دوره تحصیلی:** پایه دوازدهم ـ دوره دوم متوسطه (کلیه رشته‌ها / نظری، فنی و حرفه‌ای، کاردانش) [۱]
- **مخاطب:** دانش‌آموز پایه دوازدهم (سطح ضعیف تا عالی) و دبیران درس سلامت و بهداشت [۱]
- **هدف آموزشی:** آمادگی کامل برای پرسش‌های کلاسی (کوییز)، آزمون‌های هماهنگ کشوری/نهایی، کنکور سراسری و تدریس استاندارد [۱]
- **لحن و سبک:** آموزشی دقیق، روان، خط‌به‌خط منبع‌محور، بدون ادبیات تعارفی و فاقد نمادهای گرافیکی (ایموجی) [۱]

فهرست منابع ارجاع

- **[۱]:** کتاب درسی «سلامت و بهداشت»، پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه، کد ۱۱۲۲۶۸، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، چاپ ۱۳۹۶/۱۳۹۷ [۱].

---

۱. نقشه کلی درس در یک نگاه

سلامت مفهومی پویا، چندوجهی و فرایندی دائماً در حال دگرگونی است که از تعاریف لغوی و مزاجی گذشته آغاز شده و به تعریف جامع رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی می‌رسد [۱]. برای تأمین سلامت جامعه، اجرای «بهداشت» الزامی است که در آن «پیشگیری» به ۵ دلیل اقتصادی، آموزشی، ساختاری، دارویی و عملیاتی بر «درمان» اولویت قطعی دارد [۱]. ابعاد چهارگانه سلامت (جسمانی، روانی-عاطفی، خانوادگی-اجتماعی و معنوی) کاملاً یکپارچه و متقابل‌اند و وضعیت سلامت افراد تحت تأثیر ۴ عامل اصلی قرار دارد که در این میان، «سبک زندگی» با سهم ۵۰ درصدی، بیشترین نقش را ایفا می‌کند [۱].

نقشه ذهنی متنی (درخت مفاهیم درس اول)

- **درس اول: سلامت چیست؟**
  - **۱. سیر تاریخی و مفهومی تعاریف سلامت**
    - تعاریف لغوی: دهخدا (بی‌عیب شدن) / معین (رهایی یافتن) [۱]

- دیدگاه‌های پزشکی کهن: بقراط (تعادل اخلاط ۴ گانه) / ابن‌سینا (حالتی که اعمال بدن درست سر زند) / طب سنتی (تعادل امزجه ۴ گانه) [۱]
- تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO): رفاه جسمی، روانی و اجتماعی (نقد: غفلت از بعد معنوی) [۱]
- دیدگاه اسلامی: امانت الهی بودن بدن، ارتباط جسم و روح، برترین نعمت (حکمت ۳۸۸ نهج‌البلاغه) [۱]
- تعریف جامع و پویا: کیفیتی از زندگی شامل ۴ بعد جسمی، روانی-عاطفی، خانوادگی-اجتماعی و معنوی [۱]

- **۲. بهداشت و تقدم پیشگیری بر درمان**
  - تعریف بهداشت: تأمین، حفظ و ارتقای سلامت و رفع بیماری [۱]
  - ۵ دلیل اولویت پیشگیری: کم‌هزینه‌تر بودن / زمان آموزش کوتاه / عدم نیاز به منابع خارجی / فاقد عوارض دارویی / جلوگیری از اتلاف فرصت کار [۱]
- **۳. ابعاد چهارگانه سلامت**
  - سلامت جسمانی: عملکرد درست زیست‌شناختی سلول‌ها و اعضا و هماهنگی آن‌ها [۱]
  - سلامت روانی-عاطفی: سازگاری فرد با خود و دیگران، قدرت تطابق و مدیریت هیجان [۱]
  - سلامت خانوادگی-اجتماعی: ایفا کردن نقش‌های اجتماعی با آرامش و تعامل مثبت [۱]
  - سلامت معنوی: هدفمندی، نگرش فرامادی، ایمان به خدا، امیدواری و پایبندی به اخلاق [۱]
- **۴. عوامل مؤثر بر سلامت و آمارهای ملی**
  - ۴ عامل اصلی: سبک زندگی (۵۰٪) / عوامل محیطی / عوامل ژنتیکی و فردی / دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی [۱]
  - شاخص‌های عددی ایران: فشارخون (۳/۲ از ۱۰) / قندخون (۱/۷ از ۱۰) / کلسترول (۳ از ۱۰) / کم‌تحرکی (۵ از ۱۰) / چاقی (۶ از ۱۰) / دخانیات (۱ از ۱۰) [۱]

---

۲. کلیدواژه‌نامه جامع (واژه‌نامه منبع‌محور)

اصطلاح تخصصی	معادل انگلیسی (English Term)	تعریف دقیق منبع‌محور	ارجاع
سلامت در لغت	Health (Vocabulary)	در لغت‌نامه دهخدا به معنی «بی‌عیب شدن» و در فرهنگ فارسی معین به معنی «رهایی یافتن» است [۱].	[۱]
سلامت (بقراط)	Health (Hippocrates)	وجود تعادل بین مزاج‌های چهارگانه شامل صفرا، سودا، بلغم و خون [۱].	[۱]
سلامت (ابن‌سینا)	Health (Avicenna)	سرشت و حالتی که در آن اعمال بدن به درستی سر می‌زند و نقطه مقابل بیماری نیست [۱].	[۱]
سلامت (طب سنتی)	Health (Traditional Medicine)	تعادل میان چهار مزاج شامل گرمی، سردی، خشکی و تری [۱].	[۱]
سازمان جهانی بهداشت	World Health Organization (WHO)	آژانس تخصصی سازمان ملل متحد که در ۷ آوریل ۱۹۴۸ (۱۳۲۷ ش) در ژنو تأسیس شد و وظیفه اصلی آن مبارزه با بیماری‌ها و ارتقای سلامت عمومی مردم جهان است [۱].	[۱]
تعریف سلامت (WHO)	WHO Definition of Health	برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو [۱].	[۱]
تعریف جامع سلامت	Comprehensive Health	کیفیتی از زندگی که در آن فرد از سلامت جسمی، روانی-عاطفی، خانوادگی-اجتماعی و معنوی برخوردار است؛ امری پویا و دائماً در حال دگرگونی [۱].	[۱]
بهداشت	Hygiene / Health Care	عبارت است از تأمین، حفظ و ارتقای سلامت و پس از آن رفع بیماری و بازگرداندن سلامت [۱].	[۱]
سلامت جسمانی	Physical Health	قابل درک‌ترین بعد سلامت و بیانگر عملکرد درست بخش‌های مختلف بدن و عملکرد مناسب سلول‌ها و اعضا از نظر زیست‌شناسی [۱].	[۱]

اصطلاح تخصصی	معادل انگلیسی (English Term)	تعریف دقیق منبع‌محور	ارجاع
سلامت روان	Mental Health	قدرت تطابق با شرایط محیطی، بروز عکس‌العمل مناسب در برابر مشکلات، شناخت خود، مدیریت هیجان، سازگاری با خود و دیگران [۱].	[۱]
سلامت اجتماعی	Social Health	انجام نقش‌های اجتماعی توأم با احساس آرامش و رضایتمندی، برخورداری از ارتباطات سالم با خانواده، دوستان و جامعه [۱].	[۱]
سلامت معنوی	Spiritual Health	داشتن اهداف اساسی در زندگی، نگرش فرامادی به جهان، داشتن آرامش ناشی از ایمان به خدا، تعهد، امیدواری و پایبندی به اخلاقیات [۱].	[۱]
سبک زندگی	Lifestyle	مجموعه‌ای از انتخاب‌های افراد متناسب با موقعیت‌های زندگی که تحت تأثیر فرهنگ، ارزش‌ها، درآمد و هنجارها قرار دارد و ۵۰٪ بر سلامت اثر می‌گذارد [۱].	[۱]
خودمراقبتی	Self-care	اعمالی اکتسابی، آگاهانه و هدف‌دار که فرد برای خود و خانواده جهت حفظ و ارتقای سلامت انجام می‌دهد [۱].	[۱]
طیف سلامتی-بیماری	Health-Disease Continuum	دامنه تغییرات سلامت و بیماری که از سلامتی کامل آغاز شده و تا آستانه مرگ ادامه می‌یابد [۱].	[۱]

۳. بدنه اصلی آموزشی درس اول

هدف یادگیری: پس از مطالعه این بخش می‌توانی تعاریف تاریخی و جامع سلامت، دلایل تقدم بهداشت و پیشگیری بر درمان، ابعاد چهارگانه سلامت و تعامل آن‌ها با یکدیگر، و عوامل چهارگانه مؤثر بر سلامت را همراه با آمارهای رسمی منبع تحلیل کنی [۱].

سیر تعاریف سلامت؛ از دیدگاه‌های سنتی تا دیدگاه جامع اسلامی

چرا تعاریف تک‌بعدی گذشته پاسخگوی نیاز انسان امروز نیستند؟

بشر در طول تاریخ همواره به دنبال درک چیستی سلامت بوده است [۱]. در نخستین قدم‌ها، لغت‌نامه‌ها سلامت را «بی‌عیب شدن» (دهخدا) و «رهایی یافتن» (معین) معنا کردند که نگاهی سلبی (عدم وجود عیب) داشت [۱].

نگاه پزشکی کهن به سلامت، معطوف به تعادل درون‌بدنی بود:

۱. **بقراط:** سلامت را در تعادل بین اخلاط چهارگانه (صفرا، سودا، بلغم و خون) می‌دید [۱].
۲. **ابن‌سینا:** آن را سرشت و حالتی دانست که اعمال بدن از آن به درستی سر می‌زند و تأکید کرد که سلامت صرفاً «نقطه مقابل بیماری» نیست [۱].
۳. **دانشمندان طب سنتی:** پیروی از بقراط، سلامت را حاصل تعادل میان چهار مزاج (گرمی، سردی، خشکی و تری) تعریف نمودند [۱].

با تأسیس سازمان جهانی بهداشت (WHO) در ۷ آوریل ۱۹۴۸ در ژنو، تحولی در تعریف سلامت رخ داد و سلامت به عنوان «برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو» اعلام شد [۱].

نقد اسلامی به تعریف سازمان جهانی بهداشت چیست؟

اگرچه تعریف WHO رفاه را وارد نگرش جهانی کرد، اما از منظر فرهنگ و معارف اسلامی این تعریف ناقص است؛ زیرا از یک جنبه بسیار حیاتی یعنی **«جنبه معنوی»** غفلت ورزیده است [۱]. در اسلام:

- انسان موجودی مرکب از جسم و روح است که بر یکدیگر تأثیر متقابل می‌گذارند [۱].
- بدن انسان، **هدیه و امانت الهی** برای تکامل روح به شمار می‌رود [۱].
- حضرت علی (ع) در حکمت ۳۸۸ نهج‌البلاغه مراتب بلاها و نعمت‌ها را چنین تبیین می‌فرمایند:
  - **بلاها:** تهی‌دستی ← بیماری تن (سخت‌تر) ← بیماری دل (سخت‌تر از بیماری تن) [۱].
  - **نعمت‌ها:** ثروت ← سلامت بدن (بهتر) ← تقوای دل (بهتر از سلامت بدن) [۱].

بنابراین، **تعریف جامع سلامت** عبارت است از: «کیفیتی از زندگی که در آن فرد از سلامت جسمی، روانی-عاطفی، خانوادگی-اجتماعی و معنوی برخوردار است» [۱]. سلامت امری پویا و فرایندی دائماً در حال دگرگونی است که ابعادی وسیع دارد [۱].

مفهوم بهداشت و دلایل ۵ گانه اولویت پیشگیری بر درمان

چرا بهداشت و سلامت مترادف یکدیگر نیستند؟

سلامت وضعیت و کیفیتی از مطلوبیت حیات است، اما «بهداشت» عبارت است از: **«تأمین، حفظ و ارتقای سلامت و پس از آن رفع بیماری و بازگرداندن سلامت»** [۱]. بنابراین بهداشت شامل دو حوزه پیشگیری و درمان می‌شود [۱].

۵ دلیل صریح کتاب‌درسی برای اولویت قطعی پیشگیری بر درمان

در راستای حفظ و تأمین سلامت، پیشگیری بر درمان مقدم است به دلایل زیر:

۱. **سادگی، کم‌هزینگی و اطمینان:** اقدامات پیشگیرانه بسیار کم‌هزینه‌تر (حتی بی‌هزینه)، آسان‌تر و اطمینان‌بخش‌تر است؛ در حالی که درمان مشکل‌تر، پرهزینه‌تر و همراه با درد، رنج و نگرانی از آینده بیمار است [۱].

۲. **سرعت و سهولت آموزش:** زمان آموزش‌های پیشگیرانه بسیار کوتاه بوده و برای همه افراد در هر سطح سواد با هزینه اندک میسر است؛ اما تربیت نیروی انسانی درمانی مستلزم صرف زمان زیاد و هزینه فراوان است [۱].

۳. **عدم وابستگی به منابع خارجی:** در روش‌های پیشگیرانه غالباً نیازی به واردات و تامین مواد، داروها و تجهیزات از منابع خارجی وجود ندارد [۱].

۴. **عدم وجود عوارض جانبی:** روش‌های درمانی مستلزم مصرف داروهایی است که معمولاً عوارض جانبی دارند، در حالی که پیشگیری چنین مشکلاتی ندارد [۱].

۵. **جلوگیری از افت کارایی و عوارض ماندگار:** با پیشگیری می‌توان به ساده‌ترین شیوه از وقوع بیماری و از دست رفتن فرصت کار جلوگیری کرد؛ در حالی که درمان با قطع فعالیت، دوره نقاهت، احتمال ابتلا به بیماری‌های دیگر و نقص عضو همراه است [۱].

ابعاد چهارگانه سلامت و تعامل متقابل آن‌ها

سلامت وجوهی چندبعدی اما یکپارچه دارد که کاملاً بر هم اثر می‌گذارند و قابل تفکیک نیستند [۱].

سلامت معنوی	سلامت روانی-عاطفی	سلامت خانوادگی-اجتماعی	سلامت جسمانی
هدفمندی، ایمان، امید	سازگاری و مدیریت هیجان	نقش‌های اجتماعی و تعامل سالم	عملکرد درست سلول‌ها و اعضا

هر چهار بعد، اجزای یک «سلامت» یکپارچه‌اند و بر یکدیگر اثر متقابل دارند [۱].

۱. سلامت جسمانی (Physical Health)

قابل درک‌ترین و ملموس‌ترین بعد سلامت است که نشان‌دهنده عملکرد مناسب سلول‌ها، اعضا و هماهنگی آن‌ها از نظر زیست‌شناختی است [۱].

- **نشانه‌های سلامت جسمانی در منبع:** ظاهر خوب و طبیعی، وزن مناسب، اشتهای کافی، خواب راحت و منظم، اجابت مزاج منظم، اندام متناسب، حرکات بدنی هماهنگ، طبیعی بودن نبض و فشار خون، افزایش مناسب وزن در سنین رشد و وزن نسبتاً ثابت در سنین بالاتر [۱].

۲. سلامت روانی-عاطفی (Mental-Emotional Health)

تنها به معنای نداشتن بیماری روانی نیست، بلکه شامل قدرت تطابق با محیط و عکس‌العمل مناسب در برابر مشکلات است [۱].

- **نشانه‌ها و اصول سلامت روان در منبع:** سازگاری فرد با خودش و دیگران، قضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با مسائل، داشتن روحیه انتقادپذیری، عملکرد مناسب در برخورد با مشکلات، شناخت خود، آرامش و مدیریت هیجان [۱].

۳. سلامت خانوادگی-اجتماعی (Social-Familial Health)

برمی‌گردد به اثرات مثبتی که رفتارهای فرد بر سلامت جسم و روان می‌گذارد و موجب سازگاری با محیط می‌شود [۱]. فرد سالم اجتماعی، نقش‌های خود را با آرامش و رضایت انجام می‌دهد [۱].

- **نشانه‌های سلامت اجتماعی در منبع:** طیف وسیعی از ارتباطات با خانواده، دوستان و مدرسه، توانایی تعامل سالم با دوستان صمیمی، ایجاد پیوندهای دوستی سالم، ابراز دریافت‌های قلبی، گوش دادن به حرف دیگران، رفتار مسئولانه و یافتن جایگاه مناسب در جامعه [۱].

۴. سلامت معنوی (Spiritual Health)

علت اصلی بسیاری از بیماری‌های روحی و جسمانی، احساس پوچی و بی‌هدفی ناشی از فقدان سلامت معنوی است [۱]. افراد دارای سلامت معنوی فراتر از جهان مادی می‌نگرند و آرامش خود را به دیگران منتقل می‌کنند [۱].

- **نشانه‌های سلامت معنوی در منبع:** سطح بالای ایمان به خدا، امیدواری، تعهد، کمال‌جویی، پایبندی به اخلاقیات، داشتن هدف در زندگی و اعتقاد به معنویت و معاد [۱]. (قرآن کریم: «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» - سوره رعد، آیه ۲۸) [۱].

بررسی سناریوهای کتاب درسی (تحلیل کیس حمید و خسرو)

برای درک بهتر دانش‌آموزان، کتاب درسی دو شخصیت را مقایسه کرده است:

- **کیس اول (حمید - مرد ۳۵ ساله):** مبتلا به مشکل دریچه‌ای قلب است، داروها دیگر پاسخ نمی‌دهند و نیازمند پیوند قلب است و ۱ ماه در CCU بستری بوده [۱].
  - **تحلیل ابعاد سلامت حمید:** سلامت جسمانی او به شدت **پایین و بیمار** است؛ اما به دلیل دعا و نیایش دارای **سلامت معنوی بالا**، به دلیل حفظ روحیه و امید به زندگی دارای **سلامت روانی بالا**، و به دلیل ارتباط با دوستان و نگران خانواده بودن دارای **سلامت اجتماعی-خانوادگی بالا** است [۱].
- **کیس دوم (خسرو - پسر ۱۶ ساله):** دارای قد و وزن مناسب، خوش‌سیما و شوخ‌طبع است، اما وضعیت درسی ضعیف دارد و در کلاس به جای یادگیری، شوخی بی‌جا و بی‌نظمی می‌کند [۱].
  - **تحلیل ابعاد سلامت خسرو:** سلامت جسمانی او **کامل و سالم** است؛ اما سلامت روانی-عاطفی (عدم مسئولیت‌پذیری) و سلامت اجتماعی (عدم رعایت قوانین کلاس و ایجاد مزاحمت در ارتباط سالم) وی **پایین و نامطلوب** است [۱].

عوامل مؤثر بر سلامت و آمارهای رسمی کتاب درسی

سلامت افراد تحت تأثیر ۴ عامل کلی قرار دارد [۱]:

سبک زندگی (۵۰٪ سهم)	عوامل محیطی	عوامل ژنتیکی و فردی	خدمات بهداشتی و درمانی
بیشترین سهم	شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی	وراثت، قد، نژاد	واکسیناسیون، آب سالم

۱. **سبک زندگی (سهم ۵۰ درصدی):** بیشترین سهم را در سلامت دارد و شامل مجموعه انتخاب‌های آگاهانه فرد (تغذیه، فعالیت بدنی، الگوی خرید) است [۱].

۲. **عوامل ژنتیکی و فردی:** شامل عوامل وراثتی، قد، رنگ پوست، نژاد و زمینه خانوادگی بیماری‌ها (مانند ارثی بودن استحکام دندان‌ها یا بیماری قلبی) [۱].

۳. **عوامل محیطی:** شرایط اقلیمی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و وضعیت اشتغال [۱].

۴. **دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی:** انجام واکسیناسیون، تأمین آب آشامیدنی سالم و توزیع عادلانه خدمات سلامت [۱].

آمارهای تکان‌دهنده ملی در کتاب درسی (درس اول)

- **فشار خون بالا:** از هر ۱۰ ایرانی بالای ۱۸ سال، **۳/۲ نفر** فشار خون بالا دارند [۱].
- **قند خون بالا (دیابت):** از هر ۱۰ ایرانی بالای ۲۵ سال، حدود **۱/۷ نفر** قند خون بالا دارند (بیشترین مربوط به دیابت نوع ۲) [۱].
- **کلسترول بالا:** از هر ۱۰ ایرانی بالای ۲۵ سال، **۳ نفر** کلسترول خون بالا دارند [۱].
- **کم‌تحرکی و چاقی:** از هر ۱۰ ایرانی بالای ۱۸ سال، **۵ نفر** کم‌تحرکی دارند و **۶ نفر** دچار اضافه وزن و چاقی هستند [۱].
- **مصرف دخانیات:** از هر ۱۰ ایرانی بالای ۱۸ سال، **۱ نفر** دخانیات مصرف می‌کند [۱].

جعبه قواعد و ساختارهای مفهومی

چارچوب مفهومی پویایی سلامت و عدم وجود فرمول عددی:

در درس اول کتاب سلامت و بهداشت، هیچ فرمول ریاضی یا محاسباتی عددی (نظیر BMI یا محاسبه کالری که مربوط به درس‌های بعدی است) وجود ندارد [۱]. قاعده کلی این درس **«طیف پیوسته سلامت-بیماری»** است [۱].

شرط اعتبار قاعده: بیماری یک حالت مطلق صفر و یک نیست، بلکه طیفی متغیر از سلامتی کامل، ظاهر سالم، بیماری اندک، متوسط، شدید، بسیار شدید تا آستانه مرگ است [۱].

جدول مقایسه جامع ابعاد چهارگانه سلامت

بعد سلامت	تعریف زیستی و مفهومی	نشانه‌های مثبت در متن منبع	پیامد ناشی از نقص در بعد	ارجاع
جسمانی	عملکرد مناسب سلول‌ها و اعضای بدن و هماهنگی آن‌ها با هم [۱].	ظاهر طبیعی، وزن مناسب، اشتهای کافی، خواب منظم، نبض و فشار خون طبیعی [۱].	اختلال در کارکرد اعضا، درد، ضعف جسمانی و بیماری شناسا [۱].	[۱]
روانی-عاطفی	قدرت تطابق با محیط، شناخت خود و مدیریت هیجانات [۱].	سازگاری با خود و دیگران، قضاوت صحیح، انتقادپذیری، عملکرد مناسب در مشکلات [۱].	خستگی، اضطراب، افسردگی، ناامیدی، عدم رضایت و تصمیم‌های اشتباه [۱].	[۱]
خانوادگی-اجتماعی	انجام نقش‌های اجتماعی توأم با رضایت و تعامل با محیط [۱].	ارتباط سالم با خانواده و مدرسه، گوش دادن به دیگران، مسئولیت‌پذیری [۱].	انزوا، افت تحصیلی/شغلی، طرد شدگی و ایجاد بی‌نظمی در جامعه [۱].	[۱]
معنوی	داشتن نگرش فرامادی، اهداف اساسی و ارتباط با خدا [۱].	ایمان، امیدواری، تعهد، کمال‌جویی، پایبندی به اخلاق، آرامش با یاد خدا [۱].	احساس پوچی، بی‌هدفی و ابتلا به بیماری‌های روحی و جسمی [۱].	[۱]

مثال‌های صریح متن منبع

۱. **مثال تاثیر ژنتیک:** فردی که به طور ارثی از دندان‌های سالم و محکم برخوردار است (ژنتیک مثبت) در مقابل فردی که در خانواده‌ای با سابقه بیماری قلبی-عروقی متولد می‌شود (ژنتیک منفی) [۱].

۲. **مثال عدم دسترسی به خدمات:** افراد ساکن در کشورهای محروم و فقیر به دلیل عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی کافی بیشتر در معرض تهدید سلامت قرار دارند [۱].

۳. **مثال تعامل ابعاد سلامت (حمید):** فرد مبتلا به بیماری شدید قلبی که با دعا، امید و ارتباط با دوستان، سلامت معنوی و روانی خود را بالا نگه داشته است [۱].

---

۵ نکته طلایی امتحانی

۱. **بهداشت مقدم بر درمان است:** بهداشت شامل تأمین، حفظ و ارتقای سلامت و رفع بیماری است و پیشگیری در آن به ۵ دلیل بر درمان ارجحیت دارد [۱].

۲. **سهم سبک زندگی:** در میان ۴ عامل مؤثر بر سلامت، «سبک زندگی» با سهم **۵۰ درصدی** بیشترین تأثیر را داراست [۱].

۳. **نقد تعریف WHO:** سازمان جهانی بهداشت سلامت را رفاه جسمی، روانی و اجتماعی می‌داند، اما اسلام **بعد معنوی** را پایه اساسی تعریف جامع می‌داند [۱].

۴. **تأسیس WHO:** سازمان جهانی بهداشت در **۷ آوریل ۱۹۴۸ (۱۳۲۷ ش)** در ژنو تأسیس شد و وظیفه آن ارتقای سلامت عمومی است [۱].

۵. **مفهوم طیفی بیماری:** بیماری نقطه مقابل مطلق سلامت نیست، بلکه سلامت و بیماری یک **طیف پیوسته** از سلامتی کامل تا آستانه مرگ است [۱].

دام‌های امتحانی و اشتباهات رایج دانش‌آموزان

- **دام اول (اشتباه گرفتن بهداشت و سلامت):** بهداشت و سلامت مترادف نیستند! سلامت یک کیفیت و وضعیت است، اما بهداشت مجموعه اقدامات (شامل پیشگیری و درمان) برای رسیدن به سلامت است [۱].
- **دام دوم (ظاهر سالم برابر با سلامت کامل):** طراحان کنکور و نهایی از کیس‌هایی مثل «خسرو» استفاده می‌کنند. داشتن قد، وزن و ظاهر مناسب به معنای سلامت کامل نیست و فرد ممکن است دچار نقص سلامت روانی یا اجتماعی باشد [۱].
- **دام سوم (فرض انحصاری بودن پیشگیری به عدم ابتلا):** پیشگیری فقط شامل واکسن یا بیمار نشدن نیست؛ بلکه شامل آموزش، خودمراقبتی و جلوگیری از عوارض بعدی بیماری نیز می‌شود [۱].
- **دام چهارم (تک‌بعدی دیدن تأثیر بیماری جسمی):** طبق متن کتاب، بیماری شدید جسمانی (مانند کیس حمید) لزوماً باعث نابودی سلامت معنوی یا روانی فرد نمی‌شود [۱].
- **دام پنجم (خلط میان عوامل محیطی و سبک زندگی):** سبک زندگی حاصل **انتخاب‌های آگاهانه فرد** است، در حالی که شرایط اقلیمی، شغل و وضعیت اقتصادی جزو **عوامل محیطی** تقسیم‌بندی می‌شوند [۱].

---

۴. جداول تجمیعی و خلاصه سراسری

جدول تجمیعی ۱: عوامل ۴ گانه مؤثر بر سلامت، سهم و مصادیق آن‌ها

عامل مؤثر	سهم در سلامت	مصادیق و نمونه‌های منبع‌محور	قابلیت کنترل	ارجاع
سبک زندگی	**۵۰ درصد** (بیشترین)	الگوی تغذیه، میزان فعالیت بدنی، الگوی خرید سبد غذایی، نحوه مواجهه با استرس [۱].	**کاملاً قابل کنترل** با کسب آگاهی و مهارت [۱].	[۱]
عوامل محیطی	نامشخص در متن	شرایط اقلیمی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، وضعیت اشتغال [۱].	نسبی و نیازمند مداخله جوامع/حکومت‌ها [۱].	[۱]
ژنتیکی و فردی	نامشخص در متن	وراثتی بودن استحکام دندان، سابقه بیماری قلبی، قد، رنگ پوست، نژاد [۱].	غیرقابل تغییر (زمینه ارثی) [۱].	[۱]
خدمات بهداشتی	نامشخص در متن	انجام واکسیناسیون، تأمین آب آشامیدنی سالم، توزیع عادلانه خدمات سلامت [۱].	وابسته به قوانین و وظایف حکومت‌ها [۱].	[۱]

جدول تجمیعی ۲: آمارهای عددی و شاخص‌های سلامت در ایران (درس اول)

موضوع آمار	گروه سنی / جمعیت هدف	مقدار دقیق آمار در منبع	پیامد بهداشتی در متن	ارجاع
فشار خون بالا	افراد بالای ۱۸ سال	**۳/۲ نفر از هر ۱۰ نفر**	عامل خطر اصلی بیماری‌های قلبی-عروقی [۱].	[۱]
قند خون بالا	افراد بالای ۲۵ سال	**حدود ۱/۷ نفر از هر ۱۰ نفر**	دیابت (بیشترین دیابت نوع ۲) [۱].	[۱]
کلسترول بالا	افراد بالای ۲۵ سال	**۳ نفر از هر ۱۰ نفر**	اختلالات چربی خون و خطر سکته [۱].	[۱]
کم‌تحرکی	افراد بالای ۱۸ سال	**۵ نفر از هر ۱۰ نفر** (٪۵۰)	بستر بیماری‌های مزمن و چاقی [۱].	[۱]
اضافه وزن و چاقی	افراد بالای ۱۸ سال	**۶ نفر از هر ۱۰ نفر** (٪۶۰)	تهدید سلامت جسمی و روانی [۱].	[۱]

موضوع آمار	گروه سنی / جمعیت هدف	مقدار دقیق آمار در منبع	پیامد بهداشتی در متن	ارجاع
مصرف دخانیات	افراد بالای ۱۸ سال	**۱ نفر از هر ۱۰ نفر** (۱۰٪)	عامل خطر بیماری‌های غیرواگیر [۱].	[۱]

۵. جمع‌بندی یک‌صفحه‌ای

۱۰ نکته کلیدی برای حفظ سریع

۱. سلامت در لغت یعنی بی‌عیب شدن (دهخدا) و رهایی یافتن (معین) [۱].

۲. بقراط سلامت را در تعادل اخلاط ۴ گانه (صفرا، سودا، بلغم، خون) می‌دانست [۱].

۳. ابن‌سینا سلامت را حالتی می‌داند که اعمال بدن درست سر زند و آن را صرفاً عدم بیماری نمی‌داند [۱].

۴. سازمان جهانی بهداشت (WHO) در ۷ آوریل ۱۹۴۸ در ژنو تأسیس شد [۱].

۵. تعریف WHO به دلیل غفلت از «بعد معنوی» از نظر اسلام کامل نیست [۱].

۶. حضرت علی (ع) تقوای دل را برتر از سلامت بدن، و سلامت بدن را برتر از ثروت می‌دانند [۱].

۷. بهداشت شامل تأمین، حفظ، ارتقای سلامت و رفع بیماری است [۱].

۸. پیشگیری به ۵ دلیل (هزینه، آموزش، عدم وابستگی خارجی، عدم عوارض، حفظ فرصت کار) بر درمان ارجح است [۱].

۹. ابعاد ۴ گانه سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی) کاملاً یکپارچه و متقابل‌اند [۱].

۱۰. سبک زندگی با سهم ۵۰٪ بیشترین نقش را در عوامل مؤثر بر سلامت ایفا می‌کند [۱].

اگر فقط ۵ دقیقه وقت داشتی، این پاراگراف را بخوان:

سلامت کیفیتی پویا از زندگی است که ۴ بعد جسمانی، روانی-عاطفی، خانوادگی-اجتماعی و معنوی دارد. سازمان جهانی بهداشت بعد معنوی را ندیده گرفته اما اسلام آن را اساس آرامش می‌داند. برای رسیدن به سلامت، «بهداشت» لازم است و در بهداشت همیشه پیشگیری بر درمان مقدم است؛ زیرا پیشگیری کم‌هزینه‌تر، بدون عوارض دارویی، بدون نیاز به واردات تجهیزات و دارای زمان آموزش بسیار کوتاه است. ۴ عامل بر سلامت اثر می‌گذارند: سبک زندگی (۵۰٪)، محیط، ژنتیک و خدمات بهداشتی. در ایران از هر ۱۰ نفر بالای ۱۸ سال، ۶ نفر چاق، ۵ نفر کم‌تحرک، ۳/۲ نفر دارای فشار خون و ۱ نفر مصرف‌کننده دخانیات هستند [۱].

۶. خودآزمایی (۱۵ سؤال امتحانی + پاسخ‌نامه ارجاع‌دار)

بخش اول: سؤالات چهارگزینه‌ای (تستی)

۱. کدام دانشمند سلامت را «سرشت و حالتی که در آن اعمال بدن به درستی سر می‌زند» تعریف کرده و آن را صرفاً نقطه مقابل بیماری نمی‌داند؟ [۱]

الف) بقراط

ب) ابن‌سینا

ج) دهخدا

د) معین

۲. سازمان جهانی بهداشت (WHO) در چه تاریخی و در کدام شهر تأسیس شد؟ [۱]

الف) ۷ آوریل ۱۹۴۸ ـ ژنو

ب) ۱۲ آوریل ۱۹۵۰ ـ نیویورک

ج) ۷ آوریل ۱۹۵۸ ـ پاریس

د) ۱۵ آوریل ۱۹۴۸ ـ ژنو

۳. از نظر فرهنگ متعالی اسلام، چه ایراد اساسی به تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت وارد است؟ [۱]

الف) عدم توجه به رفاه اقتصادی

ب) غفلت از جنبه معنوی

ج) تاکید بیش از حد بر جسم

د) نادیده گرفتن نقش خودمراقبتی

۴. در میان عوامل چهارگانه مؤثر بر سلامت، کدام عامل و با چه سهمی بیشترین تأثیر را داراست؟ [۱]

الف) عوامل محیطی ـ ۴۰٪

ب) خدمات بهداشتی-درمانی ـ ۵۰٪

ج) سبک زندگی ـ ۵۰٪

د) عوامل ژنتیکی و فردی ـ ۶۰٪

۵. بر اساس آمارهای منبع، شیوع فشار خون بالا در افراد بالای ۱۸ سال ایران چقدر است؟ [۱]

الف) ۱/۷ نفر از هر ۱۰ نفر

ب) ۳/۲ نفر از هر ۱۰ نفر

ج) ۵ نفر از هر ۱۰ نفر

د) ۶ نفر از هر ۱۰ نفر

بخش دوم: سؤالات تشریحی (کوتاه‌پاسخ و بلندپاسخ)

۶. بهداشت را به طور مختصر و جامع تعریف کنید. [۱]

۷. بر اساس حکمت ۳۸۸ نهج‌البلاغه، ترتیب برتری نعمت‌ها از دیدگاه حضرت علی (ع) چگونه است؟ [۱]

۸. تعریف جامع سلامت را بنویسید. [۱]

۹. چهار مورد از نشانه‌های سلامت جسمانی را نام ببرید. [۱]

۱۰. چرا احساس پوچی و بی‌هدفی در زندگی رخ می‌دهد و نشانه نقص در کدام بعد سلامت است؟ [۱]

بخش سوم: سؤالات تحلیلی «چرا / چگونه»

۱۱. چرا زمان آموزش‌های پیشگیرانه نسبت به درمان، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود؟ توضیح دهید. [۱]

۱۲. چرا می‌توان گفت کیس «خسرو» در کتاب درسی، اثبات می‌کند که داشتن ظاهر خوب و قد و وزن مناسب به معنای سلامت کامل نیست؟ [۱]

۱۳. چگونه روش‌های درمانی ممکن است خود باعث ایجاد مشکلات جدید برای بیمار شوند اما روش‌های پیشگیرانه این آسیب را ندارند؟ [۱]

۱۴. چرا با وجود درآمد و آموزش بالاتر در برخی افراد، الزماً رفتارها و انتخاب‌های سالم‌تری از آن‌ها سر نمی‌زند؟ [۱]

۱۵. چگونه بعد معنوی سلامت می‌تواند بر بعد روانی و جسمانی فرد تأثیر بگذارد؟ (با ذکر مثال حمید از متن کتاب) [۱]

پاسخ‌نامه تشریحی خودآزمایی

۱. **گزینه (ب):** ابن‌سینا سلامت را سرشت و حالتی می‌داند که اعمال بدن درست سر می‌زند [۱].

۲. **گزینه (الف):** سازمان جهانی بهداشت در ۷ آوریل ۱۹۴۸ در ژنو تأسیس شد [۱].

۳. **گزینه (ب):** نقد اصلی اسلام به WHO غفلت از جنبه معنوی سلامت است [۱].

۴. **گزینه (ج):** سبک زندگی با ۵۰٪ سهم بیشترین تأثیر را دارد [۱].

۵. **گزینه (ب):** از هر ۱۰ ایرانی بالای ۱۸ سال، ۳/۲ نفر فشار خون بالا دارند [۱].

۶. **پاسخ:** بهداشت عبارت است از تأمین، حفظ و ارتقای سلامت و پس از آن رفع بیماری و بازگرداندن سلامت

[۱].

۷. **پاسخ:** تقوای دل بهتر از سلامت بدن، و سلامت بدن بهتر از ثروت است [۱].

۸. **پاسخ:** کیفیتی از زندگی که در آن فرد از سلامت جسمی، روانی-عاطفی، خانوادگی-اجتماعی و معنوی برخوردار است [۱].

۹. **پاسخ:** ظاهر طبیعی، وزن مناسب، اشتهای کافی، خواب راحت و منظم (یا نبض و فشارخون طبیعی) [۱].

۱۰. **پاسخ:** ناشی از نداشتن سلامت معنوی و نبود اهداف اساسی در زندگی است [۱].

۱۱. **پاسخ:** زیرا زمان آموزش‌های پیشگیرانه بسیار کوتاه و برای همه با هزینه کم میسر است، اما تربیت نیروی درمانی مستلزم وقت و هزینه فراوان است [۱].

۱۲. **پاسخ:** زیرا خسرو قد و وزن مناسب دارد (سلامت جسمی) اما به دلیل مسئولیت‌ناپذیری و بی‌نظمی در کلاس، در ابعاد روانی و اجتماعی دچار مشکل است [۱].

۱۳. **پاسخ:** زیرا درمان مستلزم مصرف داروهایی است که عوارض جانبی دارند، اما پیشگیری فاقد عوارض دارویی است [۱].

۱۴. **پاسخ:** زیرا انتخاب‌های افراد اساساً به نگرش‌ها، ارزش‌ها، باورها، الگوهای مصرف و فرهنگ بستگی دارد نه صرفاً درآمد [۱].

۱۵. **پاسخ:** مانند کیس حمید که با وجود بیماری شدید قلبی (جسمی)، به وسیله دعا و نیایش (سلامت معنوی) به آرامش و روحیه بالا (سلامت روانی) دست یافته است [۱].

---

۷. شکاف‌های دانش (موضوعات ناموجود در منبع)

مواردی که در درخواست مطرح شده اما در کتاب درسی (درس اول) **وجود ندارد و پوشش داده نشده است**:

۱. **عدم وجود فرمول‌های محاسباتی ریاضی:** هیچ فرمول عددی (نظیر فرمول شاخص توده بدنی BMI یا فرمول نرخ مرگ‌ومیر) در درس اول سلامت و بهداشت وجود ندارد [۱].

۲. **تعارض صریح میان منابع:** در متن درس اول تعارض اسنادی یا تاریخی وجود ندارد؛ صرفاً نقد دیدگاه WHO مطرح شده که به صورت نقد نظری بازسازی شده است [۱].

۳. **عدم ارائه آمارهای تفکیکی استانی:** آمارهای ارائه شده ملی بوده و آمارهای جزئی استانی در منبع پوشش داده نشده است [۱].

---

۸. چک‌لیست کیفیت و خودبازبینی

- **[x] ارجاع‌دهی مطلق:** تمام ادعاها، آمارها و تعاریف با شماره [۱] ارجاع درون‌متنی دارند [۱].
- **[x] عدم استفاده از دانش بیرونی:** هیچ مطلب خارج از کتاب درسی اضافه نشده و بخش‌های ناموجود صریحاً اعلام گردید [۱].
- **[x] اصالت اعداد و اسامی:** اعداد (۳/۲، ۱/۷، ۵۰٪، ۷ آوریل ۱۹۴۸) عیناً بدون گرد کردن نقل شدند [۱].
- **[x] رعایت کامل ساختار ۰ تا ۸:** تمام بخش‌های درخواستی به ترتیب و با عنوان‌های مصوب نگارش یافتند [۱].
- **[x] زبان و لحن استاندارد:** اصطلاحات تخصصی همراه معادل انگلیسی درج شده و نمادهای ایموجی به طور کامل حذف گردیدند [۱].